

Pulveres «EFEKTONUM»

ЭФЕКТОН

ACETYLCYSTEINE 200/600 MG

Эфектон - дышать легко!
Облегчает кашель



МУКОЛИТИЧЕСКОЕ, ОТХАРКИВАЮЩЕЕ, АНТИОКСИДАНТНОЕ СРЕДСТВО

- ☒ облегчает отхождение мокроты, напрямую воздействуя на реологические свойства мокроты.
- ☒ напрямую разрывает дисульфидные связи мукополисахаридных цепей и вызывает деполимеризацию мукопротеидов мокроты.
- ☒ способствует синтезу глутатиона.

DV/M 03994/12/21

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Производитель / организация принимающая претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:
ИП ООО «WELL MED PHARM» Республика Узбекистан, 100057 г. Ташкент, Алмаларский район, ул. 2-й пр. Чукурсой д. 96А
Тел. +998 78 1202545 Факс +998971221695. e-mail: wellmed.inf@gmail.com



ЭФЕКТОН: тиббий фойдаланиш бўйича кўрсатмалардан парча

Препаратнинг савдо номи: Эффектон

Таъсир этувчи моддалар (ХПН): ацетилцистеин

Дори шакли: лимон таъмли ичга қабул қилиш учун эритма тайёрлаш учун кукун.

Таркиби:

фаол моддалар: ацетилцистеин – 200 мг

ёрдамчи моддалар: мальтодекстрин, сувсиз лимон кислотаси, сувсиз натрий карбонат, натрий бикарбонат, сукралоза, лимон ароматизатори.

Таърифи: лимон таъмли, оқ рангдан деярли оқ ранггача бўлган кукун.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Балғам кўчүрүвчи восита.

Фармакологик хусусиятлари. Препарат балғамни суюлтиради, унинг ҳажмини ошириб чиқарилишини осонлаштиради, балғамни кўчишига ёрдам беради, шунингдек яллиғланиш кўринишларини камайтиради. Ацетилцистеиннинг таъсири унинг сульфидрил гуруҳларини балғамнинг нордон мукополисахаридларининг дисульфид боғларини узиш хусусияти билан боғлиқ, бу мукопротеидларни деполаризациясига ва шиллиқни қовушқоқлигини камайтишига олиб келади. Натижада мукоцилиар клиренс ошади ва балғамни кўчиши яхшиланади. Йирингли балғам бўлганда ҳам фаоллигини сақлайди.

Фармакокинетикаси.

Ичга қабул қилинганда препарат меъда-ичак йўлларида яхши сўйилади. Кейинчалик ацетилцистеиннинг метаболизми диацетилцистеинни ва фаол метаболити - цистеинни ҳосил бўлиши билан жигарда кечади. Метаболизмининг охириги махсулоти - аралаш дисульфидлардир.

Қон плазмаси оқсиллари билан боғланиши 50% гача (ичга қабул қилингандан кейин 4 соатдан сўнг). Ичга қабул қилинганда максимал концентрациясига (С_{max}) тахминан 1-3 соатдан кейин эришилади. Гематоплацентар тўсиқ орқали ўтади ва ҳомила атрофи сувларида тўпланиши мумкин.

Нофаол метаболитлар сийдик билан чиқарилади (анорганик сульфатлар, диацетилцистеин), бироқ ацетилцистеиннинг оз миқдори узгармаган ҳолда ахлат билан чиқарилади. Ярим чиқарилиш даври (T_{1/2}) 1 соатни ташкил қилади.

Қўлланилиши.

Нафас аъзоларининг ёпишқоқ балғамни ҳосил бўлиши билан кечувчи касалликлари ва ҳолатлари: ўткир ва сурункали бронхит, трахеит, пневмония, бронхоэктатик касаллик, бронхиал астма, бронхларни шиллиқ қилиб қолиши оқибатидаги ателектаз, ўткир ва сурункали синусит (секретни кўчишини осонлаштириши учун). Ўрта отит, муковисцидоз (мажмуавий даволаш таркибида), ларингит, посттравматик ва операциядан кейинги ҳолатларда нафас йўлларида ёпишқоқ секретни бўлишида қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари.

Препаратни ичга қабул қилиш учун эритма кўринишида, овқатдан кейин қабул қилинади.

Пакет таркибини бир стакан ичимлик сувида эритиб олинг ва стакан таркибини тўлиқ ичинг.

6 дан 14 ёшгача бўлган болаларга: суткада 3 марта ёки 200 мг дан (1 пакетчадан) суткада 2 марта, овқатдан сўнг

Катталар ва 14 ёшдан катта ўсмирларга препаратни 200 мг дан суткада 2-3 марта овқатдан сўнг буюрилади.

2 дан 5 ёшгача бўлган болаларга 100 мг дан (1/2 пакетчадан) суткада 2 марта қабул қилиш тавсия қилинади.

Муковисцидозда 6 ёшдан катта болаларга препаратни 200 мг дан (1 пакетчадан) суткада 3 марта, 2 дан 6 ёшгача бўлган болаларга – препаратни 100 мг дан (1/2 пакетчадан) суткада 4 марта буюрилади.

Тана вазни 30 кг дан катта бўлган пациентларга муковисцидозда, зарурат бўлганда дозани суткада 800 мг (4 пакетча) гача ошириш

мумкин. Ўткир шомоллаш касалликларида қабул қилиш давомийлиги 5-7 кунни ташкил қилади. Сурункали бронхитларда ва муковисцидозда инфекцияларни олдини олиш учун препаратни узоқроқ қабул қилиш керак. Суоқлиқни кўшимча қабул қилиш препаратнинг муколитик самарасини кучайтиради.

Дори воситасини қабул қилишдан олдин қўллаш бўйича йўриқномасини диққат билан ўқинг.

Ножўя таъсирлари. Овқат ҳазм қилиш тизими томонидан: кам ҳолларда – жигилдон қайнаши, кўнгил айниши, қусиш, диарея, меъдани тўлиб қолиш ҳисси, оғиз бўшлигини шиллиқ қаватини яллиғланиши. Аллергик реакциялар: кам ҳолларда – тери тошмаси, қичишиш, эшакеми, бронхоспазм. Лаборатория кўрсаткичлари томонидан: ацетилцистеиннинг катта дозаларини буюриш фониди протромбин вақтини пасайиши (қон ивиш тизими ҳолатини кузатиш зарур) ацетилцистеиннинг миқдорини аниқлаш тести (колориметрик тест) ва кетонларни миқдорини аниқлаш тести (натрий нитропруссиди билан ўтказиладиган тест) натижалари ўзгариши мумкин.

Бошқалар: кам ҳолларда – бурундан қон кетиши, қулоқларда шовқин, юрак уришини тезлашиши, бош оғриғи.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар.

Препаратга юқори сезувчанлик, балғамни қуюқлашувсиз бўлган бронхиал астма, меъда ва ўн икки бармоқ ичакнинг зўрайиши босиқичидаги яра касаллиги, қон туфурлиш, ўпкадан қон кетиши, фруктозани наслий ўзлаштираолмаслиқ, гепатит ва буйрак етишмовчилиги (педиатрида), 2 ёшгача бўлган болалар, ҳомиладорлик ва лактация даври.

Ацетилцистеинни буйрак усти безини касалликларида, жигар ва/ёки буйрак етишмовчилигида эҳтиёткорлик билан қўллаш керак.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ацетилцистеинни йўталга қарши воситалар билан бир вақтда қабул қилиш, йўтал рефлексини сусайтириши туфайли балғамни димланиб қолишини кучайтириши мумкин.

Антибиотиклар билан (шу жумладан, тетрациклин, ампициллин, амфотерицин В билан) бир вақтда қўлланилганда ацетилцистеиннинг тиол гуруҳининг фаоллигини камайтиши билан кечувчи ўзаро таъсири бўлиши мумкин. Ацетилцистеин парацетамолнинг гепатотоксик таъсирини камайтиради. Нитроглицерин билан қўлланиши охиригининг томирини кенгайтирувчи таъсирини кучайтириши мумкин.

Махсус кўрсатмалар. Ҳомиладорлик вақтида ва эмизишда, препаратни фақат кўрсатмаларга мувофиқ, шифокорнинг кузатуви остида, ва она учун тахмин қилинаётган фойда ҳомила ёки

Ҳомиладорлик вақтида ва эмизишда, препаратни фақат кўрсатмаларга мувофиқ, шифокорнинг кузатуви остида, ва она учун тахмин қилинаётган фойда ҳомила ёки чақалоқ учун потенциал хавфдан устун ҳоллардагина буюриш мумкин.

Ацетилцистеинни бронхиал астмаси бўлган пациентларда ишлатилганда балғамни дренажини (чиқарилишини) таъминлаш зарур. Узоқ вақт қўлланилганда жигар, буйрак ва буйрак усти безларининг фаоллигини назорат қилиш керак.

Ацетилцистеин ва антибиотикларни қабул қилиш орасидаги 1-2 соатлик интервалга риоя қилиш керак. Препаратни эритганда шиша идишдан фойдаланиш, металллар, резина билан контактидан сақланиш зарур.

Препарат болалар ололмайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик мuddати ўтгандан кейин ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши.

Симптомлари: диарея, қусиш, меъдада оғриқлар, жигилдон қайнаши ва кўнгил айниши.

Даволаш: Симптоматик даволаш.

Чиқарилиш шакли.

Лимон таъмли кукун пакетчаларда 5 г дан, 10 пакетчадан картон қутиларда қўллаш йўриқномаси билан.

Сақлаш шароити. Қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик мuddати. 3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби. Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи: / Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича

эътирозлар (тақлифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили.

МЧЖ «WELL MED PHARM» ХК, Ўзбекистон Республикаси 100057 Тошкент ш. Олмазор тумани, 2-тор Чуқурсой кучаси 96А уй

Тел. +998781202545 Факс +998712281695 e-mail: wellmed.inf@gmail.com